

Ficha Técnica

Curso	Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Governo
Turma	2026.1
Pólo	Brasília
Disciplina	Políticas Públicas: Teoria e Análise
Professor	Lizandro Lui
Aluno(s)	Gustavo M. Mendes de Tarso
Data	2026
Título do trabalho	ATESTMED como decisão pública baseada em evidências: matriz decisória para triagem, risco e priorização.

1 INTRODUÇÃO

O ATESTMED pode ser compreendido como uma resposta administrativa a um cenário de elevada demanda por benefícios por incapacidade, capacidade operacional limitada e necessidade de reduzir o tempo de espera sem comprometer a consistência das decisões. Seu interesse analítico, portanto, vai além da digitalização do requerimento ou da substituição parcial da perícia presencial pela análise documental. O programa integra um processo de decisão pública no qual regras, informações, capacidades organizacionais e mecanismos de controle condicionam tanto o percurso dos requerimentos quanto os resultados produzidos pela administração.

O problema que orienta esta atividade decorre da heterogeneidade dos casos submetidos ao fluxo. Os requerimentos variam quanto à completude dos documentos, à coerência das informações clínicas, à legibilidade, ao grau de incerteza e às consequências de uma decisão equivocada. Quando o desenho institucional oferece o mesmo tratamento a situações que apresentam dificuldades distintas, pode acelerar casos que exigiriam maior cautela e, ao mesmo tempo, impor etapas desnecessárias a requerimentos suficientemente instruídos. A questão deixa, assim, de ser apenas procedimental e passa a envolver o desenho da política, sua implementação e a forma como o Estado distribui uma capacidade pericial escassa.

A hipótese que organiza o texto é que a triagem do ATESTMED pode se tornar mais consistente mediante uma matriz decisória que relacione a qualidade da evidência disponível ao risco de decidir apenas com base nos documentos apresentados. Essa matriz não substituiria o juízo técnico nem produziria automaticamente a decisão final. Sua função seria orientar o encaminhamento inicial, distinguindo casos aptos à análise documental daqueles que demandam complementação, revisão técnica, auditoria ou perícia médica presencial.

2 PERSPECTIVA TEÓRICA E CATEGORIAS ANALÍTICAS

A implementação de políticas públicas constitui o eixo teórico central da investigação. É durante a implementação que diretrizes gerais são convertidas em rotinas, filtros, classificações e decisões concretas. No ATESTMED, essa passagem ocorre quando a administração recebe o requerimento, verifica seus elementos mínimos, interpreta a documentação, avalia sua suficiência e define o percurso administrativo mais adequado. As abordagens de políticas públicas baseadas em evidências e de capacidade estatal complementam esse eixo, pois permitem examinar, respectivamente, a qualidade das informações utilizadas e as condições organizacionais necessárias para processá-las.

Nesse enquadramento, evidência não corresponde à simples presença de um documento médico no processo. Para reduzir a incerteza decisória, a informação precisa ser legível, completa, internamente coerente, clinicamente pertinente e administrativamente verificável. Um fluxo pode ampliar sua velocidade de processamento sem melhorar a qualidade das decisões quando considera equivalentes documentos que oferecem graus muito diferentes de sustentação ao

juízo administrativo. A abordagem baseada em evidências interessa justamente porque obriga a perguntar não apenas se há informação, mas se ela é adequada à decisão que se pretende tomar.

A implementação também envolve discricionariedade. Entre a regra geral e o caso concreto, profissionais e unidades administrativas precisam interpretar documentos, reconhecer lacunas e decidir quando a informação disponível é suficiente. Essa discricionariedade não é, por si, um desvio do desenho institucional; ela é parte do funcionamento de políticas que lidam com situações heterogêneas. O problema surge quando os critérios permanecem tácitos, variam excessivamente entre avaliadores ou não permitem reconstruir as razões de um encaminhamento. Uma matriz explícita pode qualificar esse espaço de julgamento sem convertê-lo em aplicação mecânica de pontuações.

A capacidade estatal, por sua vez, permite observar que a qualidade da triagem depende de recursos que não se limitam ao número de servidores. Ela envolve conhecimento técnico, sistemas de informação, interoperabilidade, supervisão, auditoria e capacidade de aprender com decisões anteriores. Em um contexto de restrição da oferta pericial presencial, encaminhar todos os casos para o mesmo tipo de avaliação não representa necessariamente maior segurança. Pode apenas consumir recursos intensivos em situações nas quais a documentação já seria suficiente, prolongando a espera daqueles que realmente necessitam de exame direto.

Desses três eixos derivam as categorias analíticas utilizadas no trabalho: qualidade documental, consistência clínica, incerteza decisória, impacto potencial do erro, complexidade interpretativa, necessidade de supervisão e adequação do encaminhamento. A qualidade documental e clínica informa o grau de suficiência da evidência. A incerteza, o impacto do erro e a complexidade compõem o risco decisório. A supervisão e o encaminhamento representam as respostas organizacionais possíveis diante de diferentes combinações entre evidência e risco.

3 OBJETO EMPÍRICO: O ATESTMED COMO FLUXO DECISÓRIO

O objeto empírico não é o ATESTMED considerado em toda a sua extensão, mas sua etapa de triagem decisória em contexto de capacidade pericial limitada. O interesse recai sobre o momento em que a administração precisa definir se os elementos disponíveis sustentam a continuidade da análise documental ou se o requerimento deve receber outro tratamento. Essa escolha condiciona o fluxo subsequente e afeta simultaneamente o tempo de resposta, o risco de erro e a utilização da estrutura pericial.

Na prática, dois requerimentos relacionados a condições clínicas semelhantes podem exigir encaminhamentos distintos. Um deles pode apresentar documento legível, período de afastamento definido, descrição funcional compatível e informações temporalmente coerentes. Outro pode conter datas divergentes, ausência de elementos essenciais ou documentação que não permita compreender a repercussão alegada. Tratar ambos como casos equivalentes enfraquece a triagem, porque ignora diferenças relevantes para a segurança da decisão. O exemplo mostra que

o problema não está em optar abstratamente entre análise documental e perícia presencial, mas em reconhecer quando cada modalidade agrega valor ao processo.

Esse recorte substitui a pergunta genérica sobre se a análise documental “funciona” por uma indagação mais precisa: em quais condições ela oferece base suficiente para uma decisão e em quais situações deve ser complementada por outros mecanismos? A mudança é importante porque afasta soluções uniformes. Em políticas marcadas por grande diversidade de casos, a qualidade do desenho depende da capacidade de modular respostas sem produzir tratamento arbitrário.

O ATESTMED é interpretado, assim, como parte de um arranjo híbrido. A análise documental pode oferecer resposta célere aos casos bem instruídos, enquanto a perícia presencial, a revisão técnica e a auditoria devem ser mobilizadas quando acrescentam informação relevante ou reduzem incertezas que os documentos não resolvem. A equidade, nesse contexto, não significa oferecer o mesmo percurso a todos, mas aplicar critérios transparentes e justificáveis a requerimentos com características semelhantes.

4 MATRIZ DECISÓRIA PARA TRIAGEM, RISCO E PRIORIZAÇÃO

A matriz proposta é um instrumento de apoio à decisão pública. Seu objetivo é organizar o julgamento inicial por meio de dois eixos: qualidade da evidência e risco decisório. A qualidade da evidência resulta da completude, legibilidade, coerência e pertinência das informações apresentadas. O risco decisório corresponde à possibilidade de que uma conclusão tomada com os elementos disponíveis produza erro relevante, especialmente quando persistem ambiguidades, inconsistências ou consequências administrativas difíceis de corrigir.

É importante esclarecer que “alto risco” não constitui uma classificação moral do requerente nem equivale automaticamente a suspeita de fraude. O risco pertence à situação decisória: ele aumenta quando a administração dispõe de pouca informação confiável, enfrenta maior complexidade interpretativa ou pode produzir consequências relevantes a partir de uma base documental frágil. Essa distinção evita que a matriz transforme incerteza administrativa em estigma dirigido ao cidadão.

A combinação entre os dois eixos produz percursos diferentes. Evidência robusta e baixo risco favorecem a conclusão pelo fluxo documental. Quando a evidência é intermediária, a complementação pode resolver lacunas sem mobilizar imediatamente a perícia presencial. Nos casos em que o risco permanece elevado, a revisão técnica, a auditoria ou o exame direto tornam-se respostas mais adequadas. A Tabela 1 explicita essas combinações.

Tabela 1 – Matriz decisória proposta para triagem no ATESTMED

Qualidade da evidência	Risco baixo	Risco intermediário	Risco elevado
Alta	Prosseguimento e possível conclusão no fluxo documental.	Análise documental com revisão técnica dirigida aos pontos de dúvida.	Revisão técnica ou auditoria, com encaminhamento presencial quando a incerteza relevante persistir.
Intermediária	Solicitação de complementação objetiva antes da conclusão.	Complementação documental seguida de revisão técnica.	Encaminhamento prioritário para avaliação aprofundada, com possibilidade de perícia presencial.
Baixa	Saneamento das pendências documentais e nova triagem.	Complementação assistida e supervisão do caso antes de qualquer conclusão.	Perícia presencial ou auditoria prioritária, conforme a natureza da insuficiência e do risco.

A matriz torna visível que a triagem é uma etapa substantiva da política. Ao definir o percurso de cada requerimento, a administração distribui tempo, atenção técnica e capacidade pericial. Uma classificação inadequada pode tanto encaminhar prematuramente um caso para decisão documental quanto ocupar a perícia presencial com situações que poderiam ser resolvidas por complementação simples. O instrumento busca reduzir esses dois tipos de desperdício sem pressupor que toda diferença possa ser capturada por regras fechadas.

A priorização também precisa ser tratada com cautela. Ela não deve resultar de uma soma automática de pontos, mas da combinação entre tempo de espera, suficiência da evidência, risco do erro e possibilidade de correção posterior. Critérios explícitos permitem justificar por que determinado caso recebeu revisão adicional ou foi encaminhado para exame presencial. Também favorecem a comparação entre unidades, a identificação de padrões decisórios e o aperfeiçoamento gradual das rotinas.

5 IMPLICAÇÕES ANALÍTICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO

A adoção de uma matriz não elimina a discricionariedade dos agentes responsáveis pela triagem. Ela oferece referências comuns para que decisões semelhantes recebam justificativas comparáveis. O julgamento profissional continua necessário, sobretudo nos casos intermediários, mas passa a ser exercido em condições de maior rastreabilidade. Dessa forma, a matriz funciona como estrutura de apoio, e não como substituta da avaliação técnica.

Há também uma consequência direta para a capacidade estatal. Ao separar requerimentos documentais simples daqueles que apresentam insuficiências relevantes, a administração pode reservar recursos mais intensivos para situações em que eles efetivamente ampliam a qualidade da decisão. A melhora esperada não se limita ao aumento do número de processos analisados. O ganho está em alinhar o tipo de caso à intensidade do tratamento administrativo, reduzindo encaminhamentos desnecessários e evitando que a busca por celeridade transfira riscos para etapas posteriores.

Esse desenho, entretanto, depende de monitoramento. Os critérios utilizados precisam ser confrontados com resultados como necessidade de retrabalho, frequência de revisões, divergências posteriores e concentração de determinados grupos em percursos mais gravosos. Caso a matriz produza distorções recorrentes, seus parâmetros devem ser revistos. Uma política orientada por evidências não pode tratar a própria ferramenta de triagem como algo imune à avaliação.

Também é necessário preservar a possibilidade de explicação e contestação. Quanto maior a influência da classificação sobre o percurso do requerimento, maior deve ser a capacidade institucional de registrar os fundamentos da escolha. A transparência não exige expor fórmulas simplificadoras ao cidadão, mas garantir que a administração consiga demonstrar quais elementos foram considerados e por que determinado encaminhamento foi adotado.

6 PERGUNTA DE PESQUISA E OBJETIVO GERAL

Pergunta de pesquisa: como uma matriz decisória baseada na qualidade da evidência e no risco decisório pode aperfeiçoar a triagem dos requerimentos do ATESTMED em contexto de capacidade pericial limitada?

Objetivo geral: analisar como a qualidade da evidência, o risco decisório e a capacidade estatal condicionam a triagem dos requerimentos do ATESTMED e propor uma matriz de apoio ao encaminhamento entre análise documental, complementação, revisão técnica, auditoria e perícia médica presencial.

7 CONCLUSÃO

A perspectiva da implementação mostra que a qualidade da política se decide nas rotinas de triagem e encaminhamento. A abordagem baseada em evidências exige avaliar a suficiência das informações, enquanto a capacidade estatal evidencia os recursos necessários para diferenciar os casos. Esses elementos permitem examinar o ATESTMED sem reduzi-lo a uma inovação tecnológica ou a uma medida de produtividade.

A matriz proposta traduz essa discussão em um instrumento analítico concreto. Ao cruzar qualidade da evidência e risco decisório, explicita percursos possíveis sem eliminar o julgamento profissional. Seu valor depende de critérios transparentes, supervisão e revisão periódica. A finalidade não é automatizar a decisão, mas tornar a triagem mais justificável, consistente e sensível às diferenças entre os requerimentos.